

Examen clinique en ORL

Plan

- I. Interrogatoire**
- II. Inspection de l'oreille et otoscopie**
- III. Examen nasal**
- IV. Examen de la cavité buccale et de l'oropharynx**
- V. Examen du pharynx**
- VI. Examen du rhinopharynx**
- VII. Examen du Larynx**
- VIII. Inspection et Palpation du cou**

I. Interrogatoire

Interrogatoire

L'interrogatoire ou anamnèse du patient doit être bien détaillé : Il faut mettre en confiance le malade qui est souvent anxieux. Il faut de la patience , de la courtoisie, de la gentillesse, rassurer le malade et surtout le laisser parler et l'orienter de temps à autre en cas d'égarement.

Interrogatoire

- Date, identification de la personne ayant rédigé l'observation.
- Mode d'arrivée à l'hôpital (adressé par qui...)
- Motif d'hospitalisation (un ou plusieurs symptômes).
- Antécédents Personnels :
 - Chirurgicaux.
 - Médicaux.
 - Allergiques.
- Antécédents Familiaux (premier degré).
- Traitements habituels ou occasionnels.
- Mode de vie
 - Contexte socioprofessionnel.
 - Contexte familial
 - Intoxications: OH, Tabac
 - Voyages, animaux de compagnie.

- Histoire de la maladie

Début : Quand (date, heure)

- Mode d'installation,
- facteur déclenchant.
- Rythme,
- durée.
- Qualité des troubles.
- Intensité,
- sévérité,
- retentissement sur le quotidien.
- Facteurs qui aggravent et soulagent.
- Manifestations associées.

- Examen physique ORL
- Examen physique général
 - Poids et signes vitaux.
 - Recherche des signes physiques (inspection, palpation, percussion, auscultation) :
 - Cardio-vasculaire.
 - Pleuro-pulmonaire.
 - Abdomen. Neurologique.
 - Locomoteur. Uro-génital.
 - Seins.
 - Aires ganglionnaires.
 - Cutanéomuqueux

- Conclusion
 - Synthétiser le problème en une courte phrase.
 - Liste des hypothèses diagnostiques par ordre de vraisemblance.
 - Ebaucher une stratégie de prise en charge.

Motif de la consultation

DIAGNOSTICS CLASSIQUES EN ORL

Obstruction nasale

« nez bouché »

- Symptôme apparemment anodin
- Évocateur d'étiologies nombreuses et variées qu'il faut avoir à l'esprit.
- Un nez bouché peut être le seul signe d'appel d'une tumeur bénigne ou maligne du nez.
- Le diagnostic repose sur un examen nasal et naso-pharyngé, qui bien mené permet d'évoquer et de poser le diagnostic étiologique

- étiologies peuvent être communes ou spécifique selon l'âge.
- Constante: obstruction mécanique
 - Déviation de la cloison nasale
 - Polypose nasosinusienne
 - Tumorale
- Intermittente: avec éternuements, prurit nasal
 - Allergie
- Chez un menuisier: il faut penser à l'adénocarcinome de l'ethmoïde professionnel

Rhinorrhée

- Écoulement nasal ou rhinorrhée aqueuse
- Symptôme d'apparence nasale
- Haute valeur sémiologique
- Peut être isolé
- Association à d'autres symptômes d'expression nasale

Conduite de l'examen

- L'interrogatoire cherche toujours:
 - Date de début des symptômes
 - Circonstances favorisantes ou déclenchantes
- L'examen des fosses nasales (rhinoscopie antérieure, endoscopie endo-nasale) peut montrer:
 - Hypertrophie des cornets
 - Muqueuse rouge

- Unilatérale et purulente
 - Chez un adulte
 - Tumeur fosse nasale
 - Infection des sinus antérieurs
 - Chez un enfant:
 - Corps étranger nasal
- écoulement antérieur abondant :
 - Rhinolicorrhée (liquide cérébrospinal)

Troubles de l'odorat

- L'odorat ou l'olfaction permet la perception des odeurs des corps volatiles.
- Les causes d'un trouble de l'odorat sont multiples
- L'interrogatoire doit chercher les circonstances de survenue du trouble olfactif
- Il peut s'agir d'une cause rhinologique , un trouble de la ventilation nasale, rétrécissement, inflammation , infection , polypose nasale
- Il faut envisager une cause centrale (atteinte des centres olfactifs)

Troubles de l'odorat

Hyposmie diminution de l'odorat

Anosmie ou perte de l'odorat

depuis un traumatisme: Fracture de la lame criblée de l'éthmoïde

Parosmie: une perception olfactive qui ne correspond pas à la stimulation

Cacosmie: une perception olfactive désagréable

Sinusite d'origine dentaire

Odynophagie

- Avec trismus
 - Phlégmon périamigdalien
- Avec torticolis
 - Abscès rétropharyngien

Hypoacousie

- Diminution de l'acuité auditive.
- De transmission: oreille externe, oreille moyenne
- De perception: oreille interne, voie auditive centrale

- Unilatérale et progressive: neurinome de l'acoustique
- Unilatérale, brutale, totale et récente: urgence thérapeutique
- Bilatérale et progressive: presbycusis
- Antécédents d'otites à répétition dans l'enfance: otite chronique ou séquelles d'otite chronique

Otorrhée

- Ecoulement de l'oreille
- Jaunâtre et bilatéral: cérumen
- Otorrhée purulente et malodorante: cholestéatome
- Ototorrhée prolongée chez un diabétique: otite externe nécrotique ou « maligne »

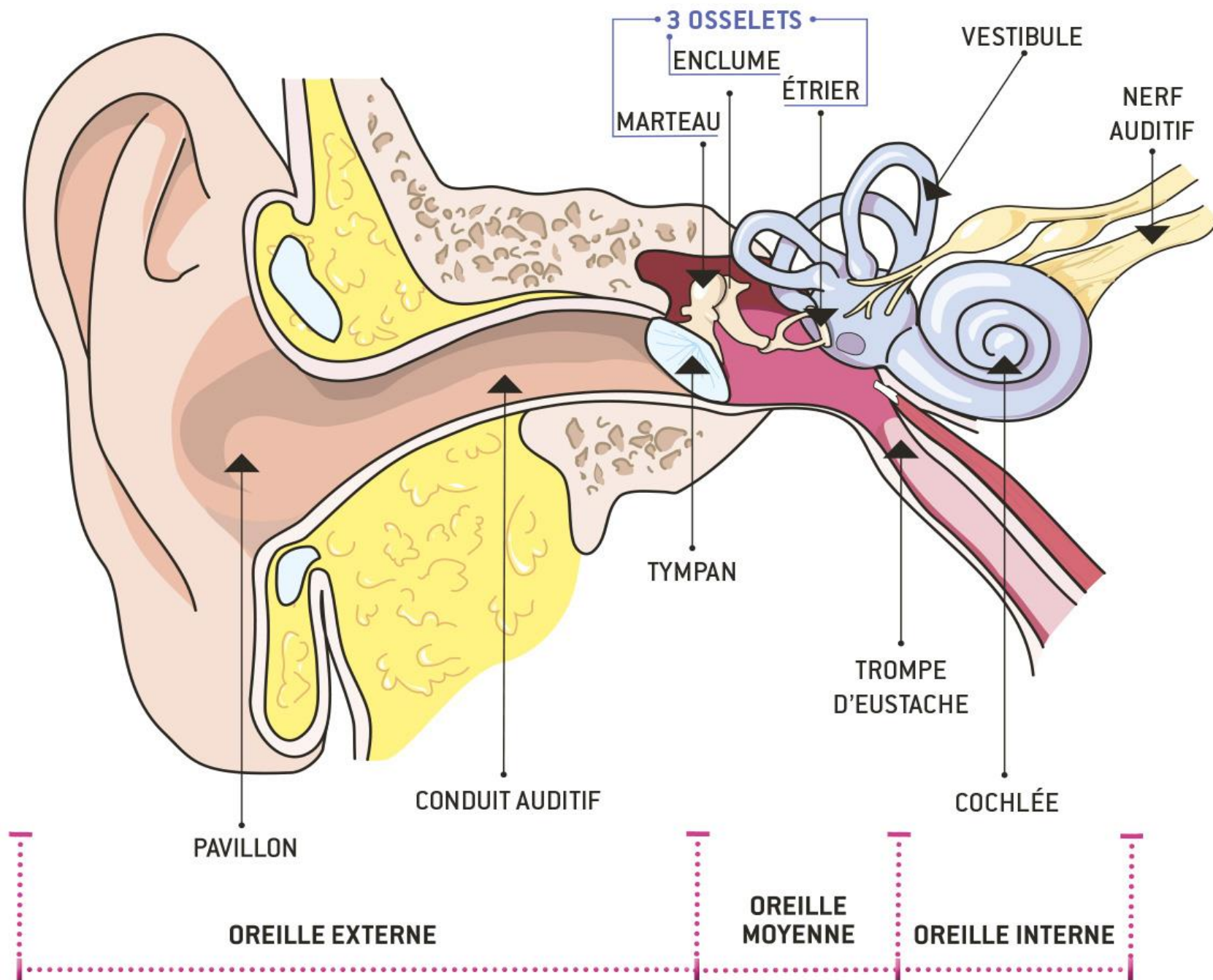
Otalgie

- Déclenchée par la mobilisation du tragus: otite externe
- Associée à une surdité sévère: otite moyenne aiguë

Vertiges

- Illusion de mouvement le plus souvent rotatoire
- Positionnels et brefs: VPPB
- Spontanés par crises de quelques heures avec symptômes auditifs unilatéraux: maladie de Ménière

III. Examen de l'oreille

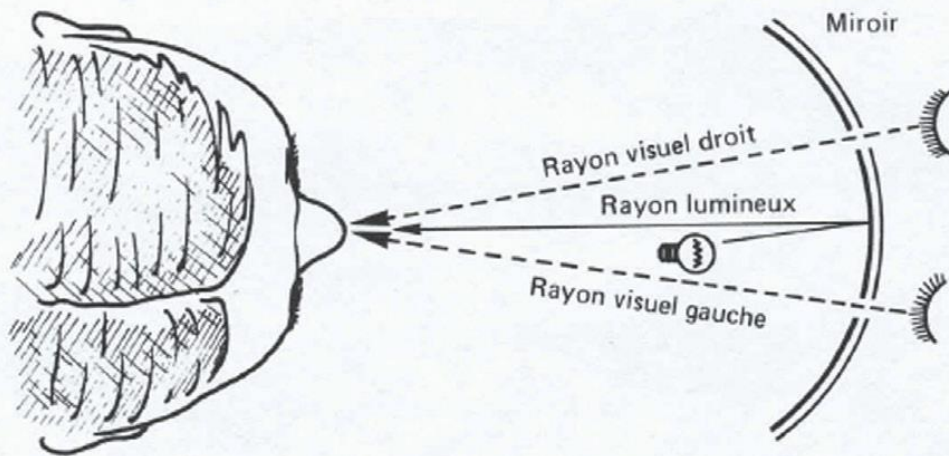


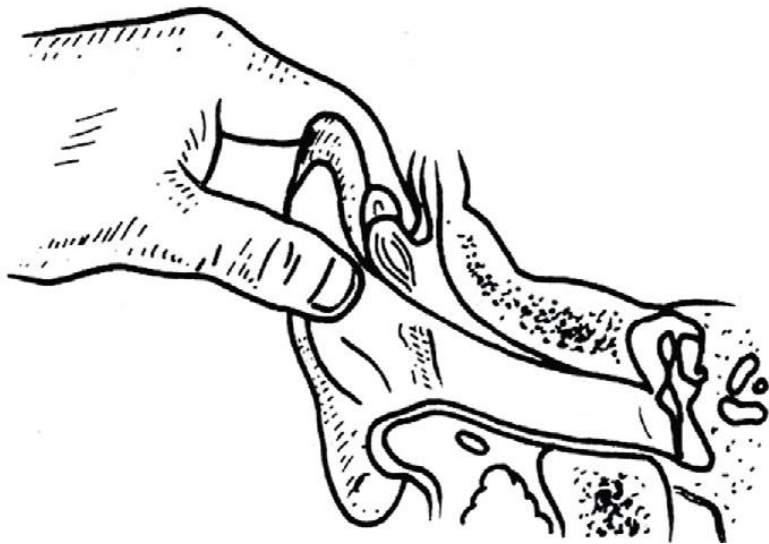
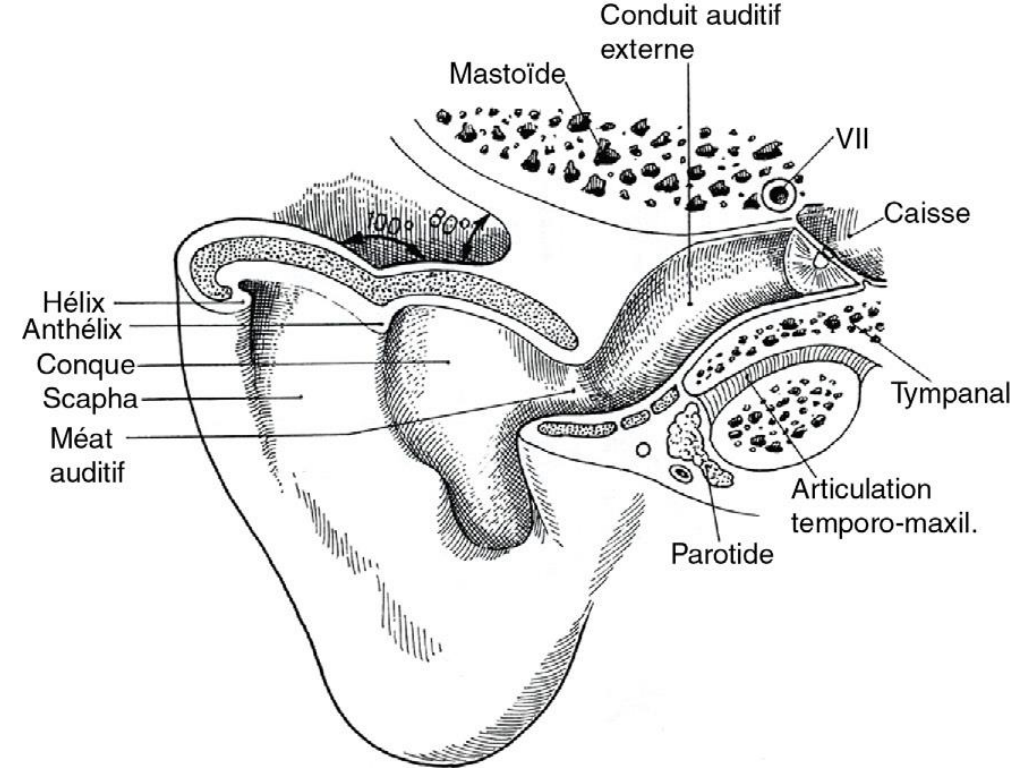
- Examiner le pavillon de l'oreille avant d'effectuer l'otoscopie
- Présence d'une cicatrice retro-auriculaire
- Nécessite un spéculum de l'oreille ou un otoscope à piles

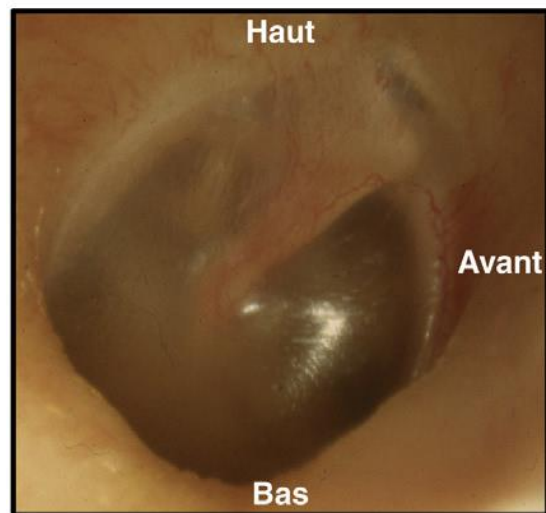
Otoscopie



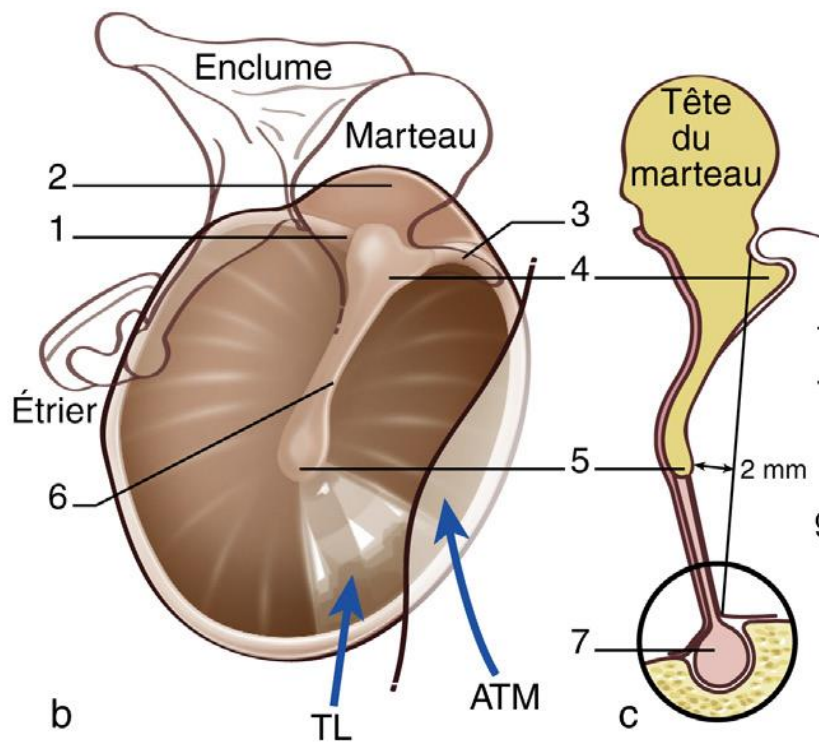
Miroir de Clar



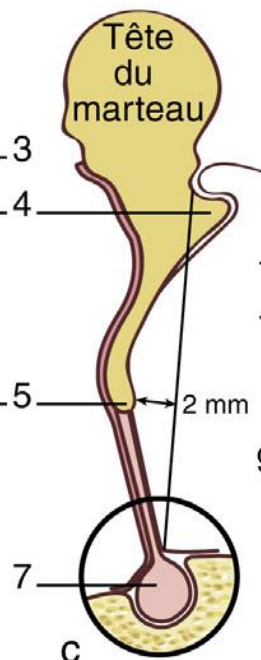




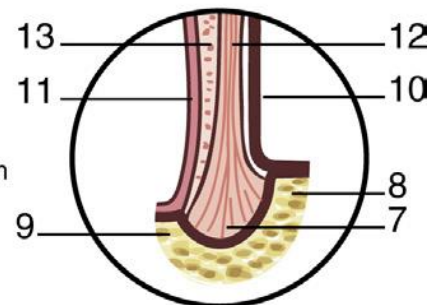
a



b

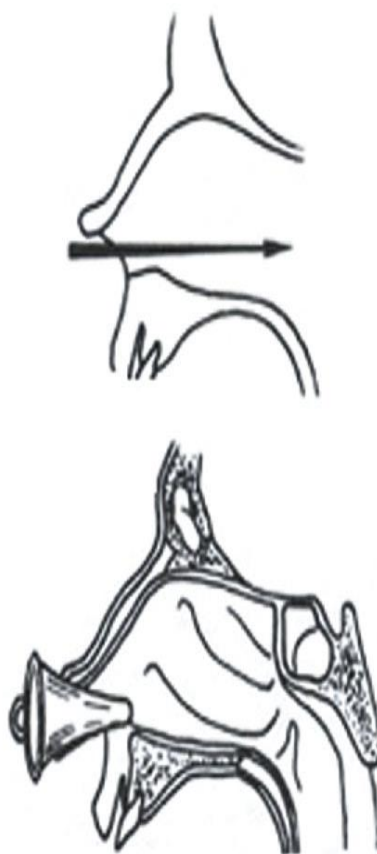
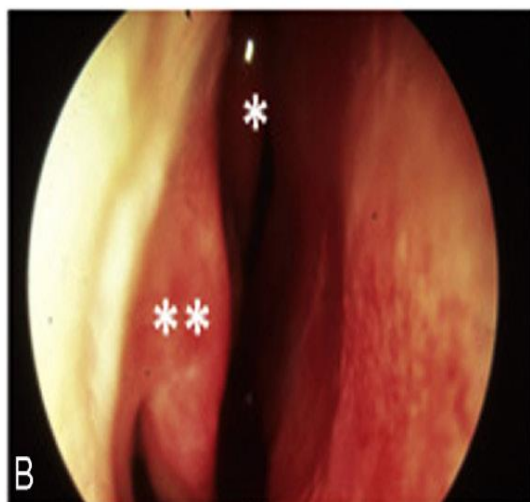


c



d

IV. Examen nasal

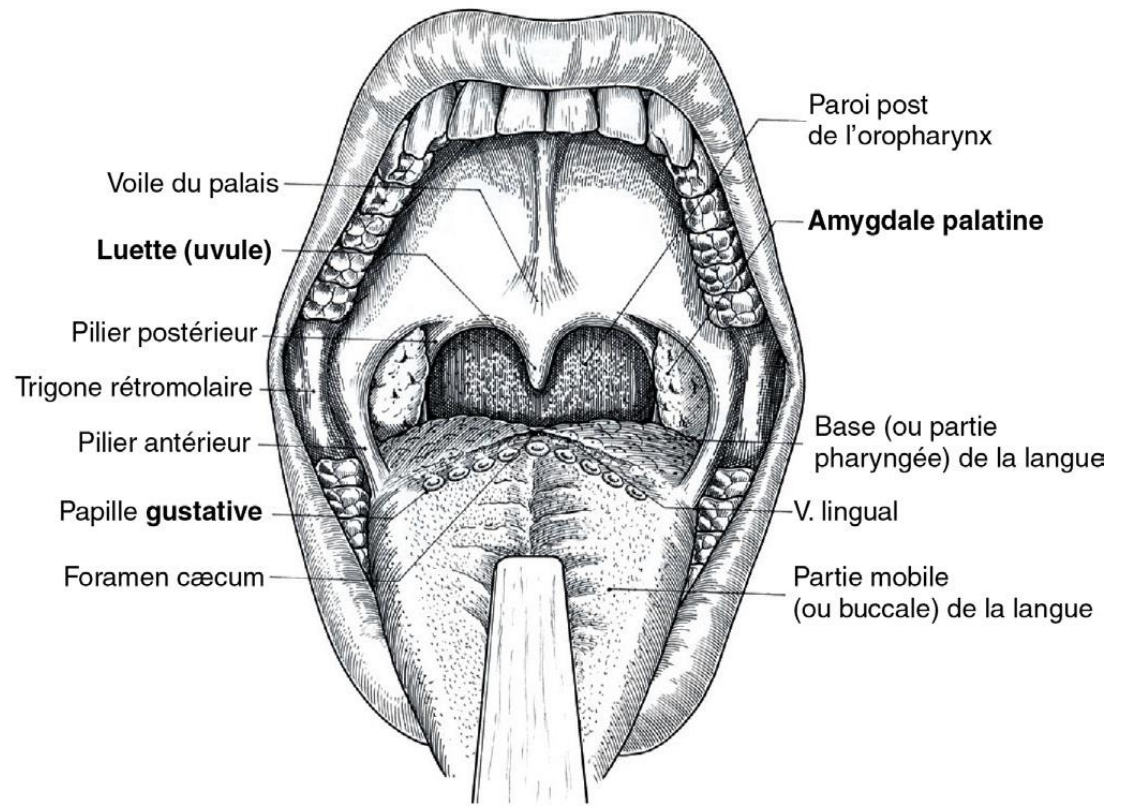


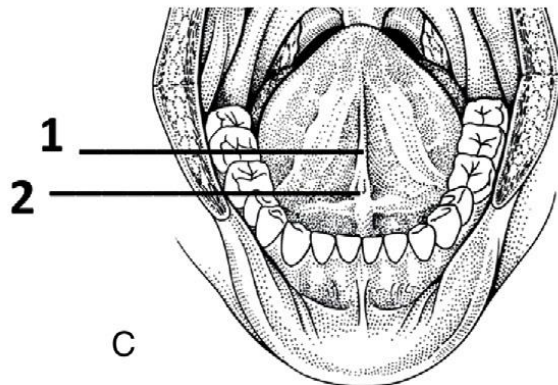
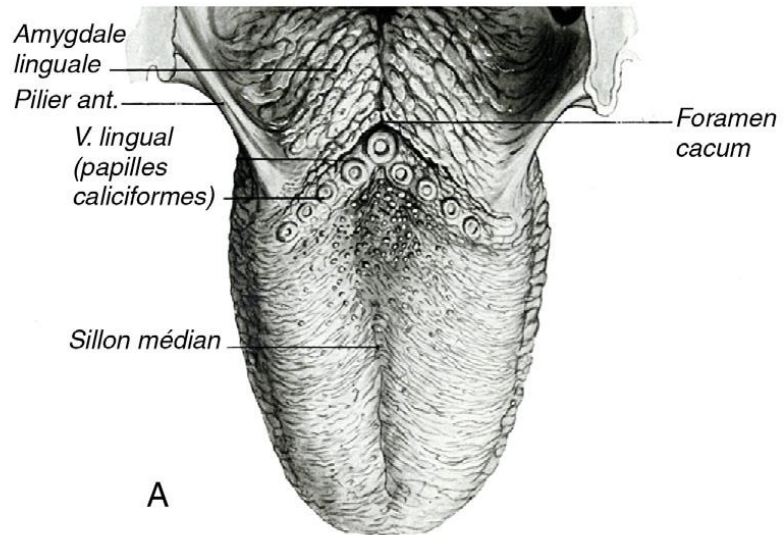
Horizontal : tête droite



Oblique : en faisant basculer
la tête en arrière

V. Examen de la cavité buccale & de l'oropharynx



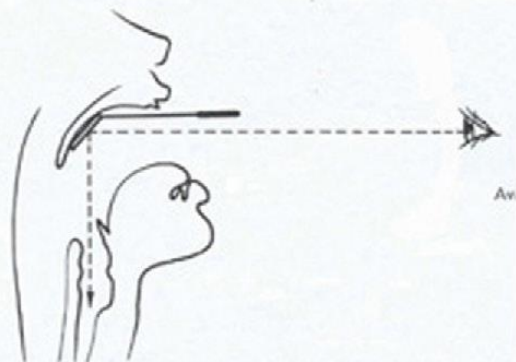


Microscopie de consultation



VII- Examen du pharynx

A



B



C

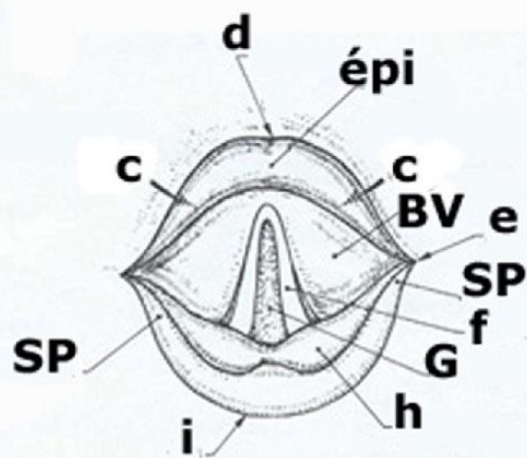
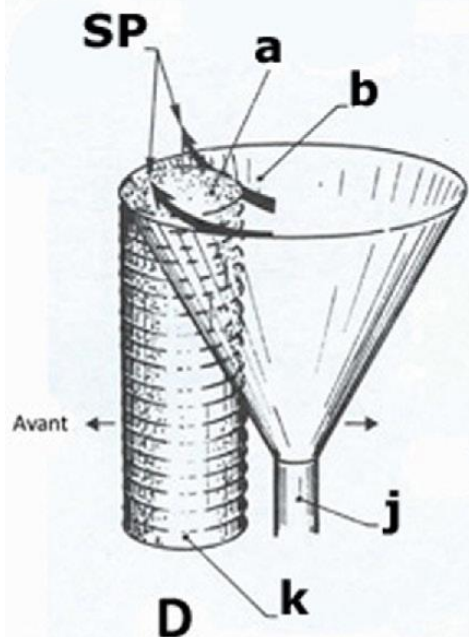


SP

a

b

Avant

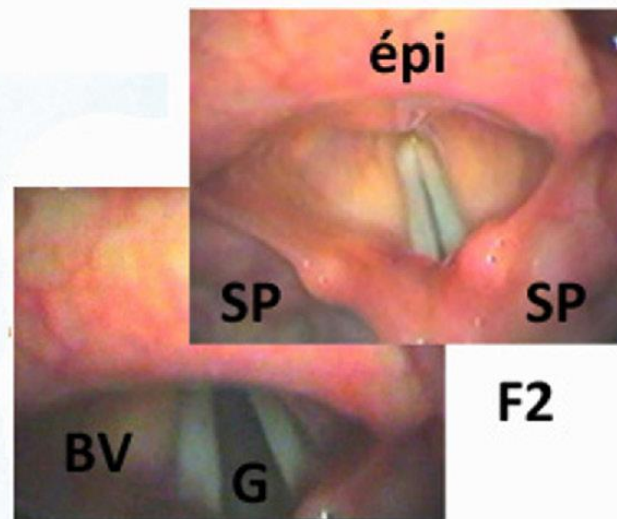


E

épi

SP

SP

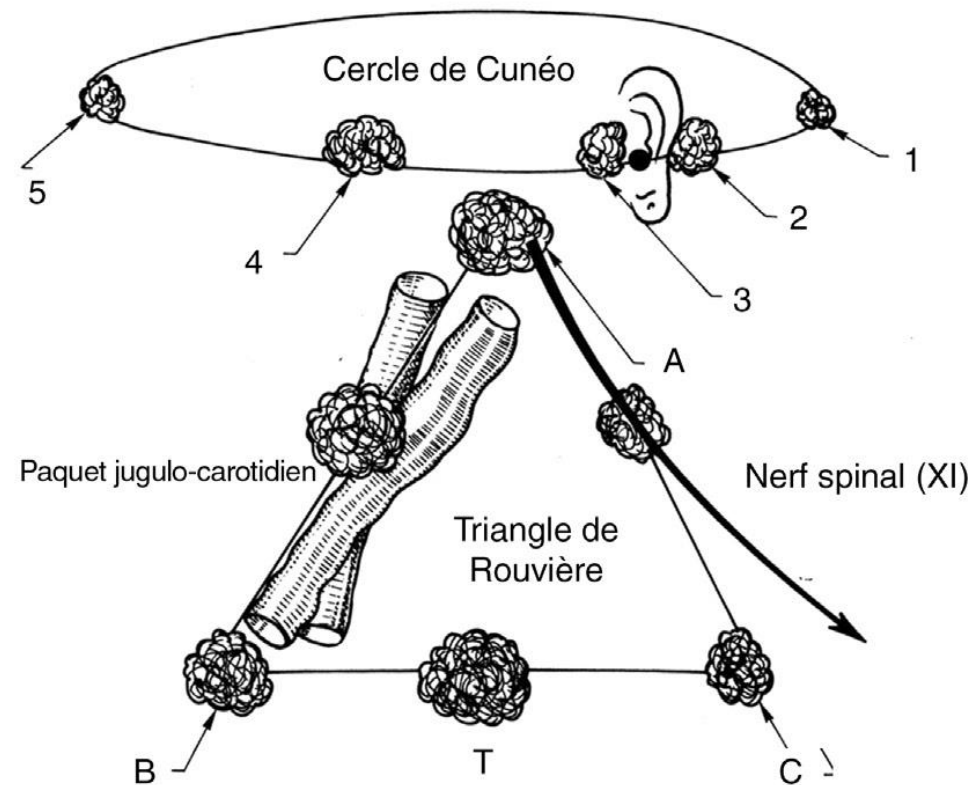


F2

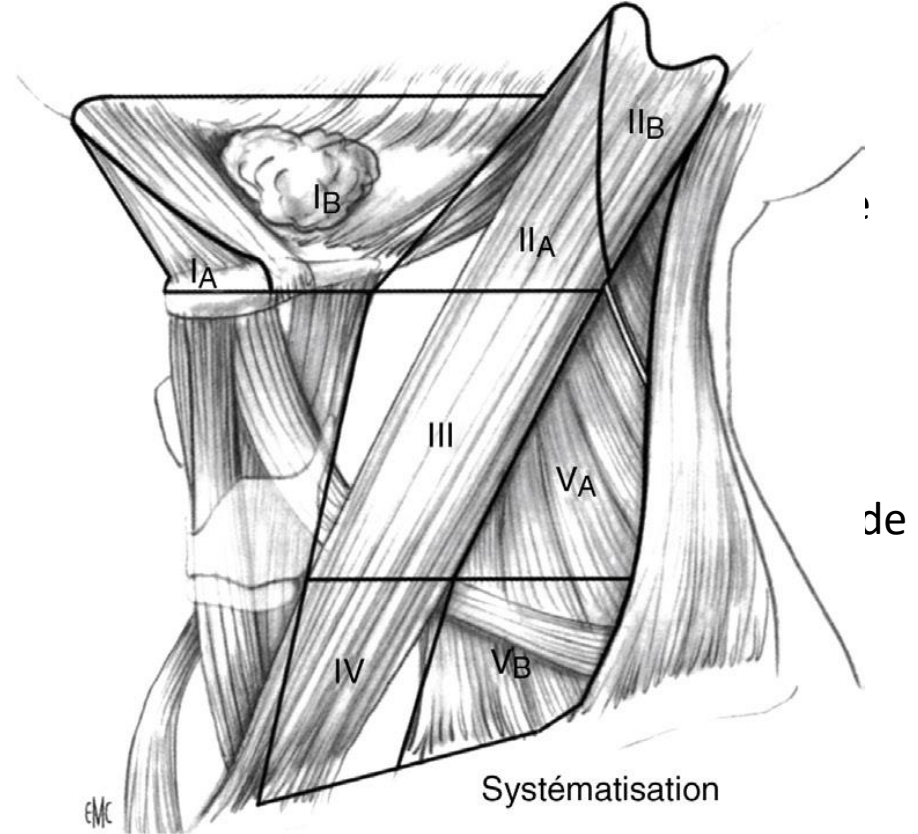
F1

IX. Palpation du cou

Elle doit être méthodique, à la recherche d'une masse suspecte.



La palpation commence par les chaînes



palpant les chaînes ganglionnaires jugulo-carotidiennes jusqu'aux régions sous-digastriques

